

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA – SÍNDROMES

SÍNDROMES CEREBRALES ORGÁNICOS AGUDOS

Afectación funcional, comienzo por lo general es brusco, trastornos de las **funciones de síntesis y cognoscitivas**, con la **afectación del nivel de vigilia como síntoma cardinal**.

Dificultan seriamente la adaptación creadora del sujeto a su medio, aunque tienden a evolucionar en breve plazo a la curación con restitución total - parcial cuando la enfermedad que expresan es correctamente diagnosticada y tratada en otras circunstancias pueden evolucionar el deterioro irreversible e incluso a la muerte.

SUB- SÍNDROME	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
SÍNDROME DE OBNUBILACIÓN	Descripción general: enfermo tranquilo, hipomímico, con descuido en los hábitos si no se le auxilia Funciones de síntesis: vigilia baja, atención distráctil, memoria disminuida, orientación muy grosera Funciones de relación: afectadas globalmente. Capacidades intelectuales: disminuidas. Funciones cognoscitivas: sin síntomas productivos, lo más significativo es la necesidad de utilizar estímulos fuertes para lograr la comunicación, pensamiento lento Funciones afectivas: indiferencia Conducta: abulia e hipoquinesia
SÍNDROME DE DELIRIUM	Descripción general: paciente agitado, sudoroso y tembloroso. Funciones de síntesis: vigilia baja; atención distráctil; memoria disminuida con evocación residual después de superado el cuadro; comprensión disminuida; orientación fluctuante que le permite, en ocasiones, ubicarse en espacio y persona, aunque instantes después se muestra totalmente desorientado Funciones de relación: afectadas globalmente. Capacidades intelectuales: disminuidas. Funciones cognoscitivas: notable riqueza alucinatoria, sobre todo visual y táctil, cuyas temáticas más frecuentes son los animales repugnantes que se le enciman, o los temas cósmicos o catastróficos n los que el paciente se siente en riesgo de muerte o agresión, a veces las alucinaciones son agradables y en forma de miniaturas, pensamiento disgregado y perseverante y su temática guarda relación con las alucinaciones. Funciones afectivas: variables, según las alucinaciones, pero con frecuencia hay ansiedad y terror. Conducta: agitación a grandes espacios, generalmente en defensa ante sus presuntos agresores y determinante de riesgos, como lanzarse al vacío o golpearse en las huidas si no es protegido; los temblores son muy significativos, sobre todo en el delirium alcohólico, que es el más característico.
SÍNDROME ONIROIDE	Descripción general: paciente en actitud contemplativa, hipomímico, con descuido de hábitos si no hay tutoría. Funciones de síntomas: vigilia baja; atención distráctil, excepto en lo relativo a sus vivencias alucinatorias en las que generalmente aparenta estar hiperconcentrado; memoria disminuida al superar el cuadro; tomada la orientación alopsíquica, conservada la autopsíquica. Funciones de relación: globalmente afectadas, comprensión disminuida. Capacidades intelectuales: disminuidas. Funciones cognoscitivas: notable riqueza alucinatoria visual de tipo escénica con temáticas no angustiosas que explican su pasividad ante las vivencias, pensamiento disgregado, divagante y lento Funciones afectivas: beatifica complacencia. Conducta: contemplativa, inmóvil.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA – SÍNDROMES

SÍNDROME DE ESTADO CREPUSCULAR

Descripción general: enfermo **agitado**, sudoroso y agresivo. Funciones de síntesis: **nivel de vigilia muy bajo**, atención distráctil para temas ajenos a sus vivencias alucinatorias, **amnesia total al concluir el cuadro** a diferencia del delirium, y el síndrome oniroide donde la norma es la posibilidad de evocar fragmentariamente lo ocurrido, comprensión disminuida y **desorientación total y sin fluctuaciones**. Funciones de relación: toma de las funciones de relación. Capacidades intelectuales: toma de las capacidades intelectuales. Funciones cognoscitivas: **alucinaciones, sobre todo visuales**, terroríficas; **pensamiento y lenguaje prácticamente nulos**. Funciones afectivas: **agresividad**, ansiedad, pánico. Conducta **agresiva, destructiva, fugitiva** y vinculada con las alucinaciones.

SÍNDROME DE CONFUSIÓN MENTAL

Descripción general: se describe el enfermo como en **agitación limitada a su cama**, con movimiento sin propósito -como enrollar la sábana- que se denominan **movimientos carfólicos**, de alto valor diagnóstico; la expresión facial es de perplejidad Funciones de síntesis: vigilia a punto de abolirse, atención muy distráctil, memoria abolida, **comprensión abolida**, desorientación total y sin fluctuaciones. Funciones de relación: abolidas. Capacidades intelectuales: prácticamente nulas Funciones cognoscitivas: predominio de **ilusiones visuales inferidas por la observación** del enfermo, **pensamiento incoherente**. Funciones afectivas: **indiferencia**. Conducta, **agitación limitada a veces con características profesionales**; el enfermo repite movimientos propios de su trabajo habitual.

SÍNDROMES CEREBRALES ORGÁNICOS CRÓNICOS

En forma opuesta a los síndromes orgánicos agudos, en este caso las **alteraciones del nivel de vigilia o de las sensopercepciones no existen o son prácticamente despreciables**, en tanto que sobresale la **afectación de las capacidades intelectuales y del carácter**. Como vemos, la esencia de estos síndromes es la **desorganización de la personalidad**. **Sus posibilidades de reversión son escasas o nulas**.

SUB-SÍNDROME

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

SÍNDROME OLIGOFRÉNICO

Descripción general: **frecuentemente distraído, descuidado en su presencia**. Funciones de síntesis: vigilia normal, **atención distráctil**, la memoria puede estar aumentada en forma mecánica, desorientación sólo en los casos más graves. Funciones de relación: **afectadas globalmente, comparables a las de un niño**. Capacidades intelectuales: **muy disminuidas**. Funciones cognoscitivas: no alteraciones sensoperceptivas, **pensamiento concreto**. Funciones afectivas: **respuestas infantiles** como intolerancia a frustraciones, incapacidad para posponer satisfacciones, cambios afectivos bruscos, dependencia, sugestibilidad. Conducta: **inconsistente y pueril**, adaptación creadora limitada.

SÍNDROME DEMENCIAL

Descripción general: **aspecto descuidado**, comunicación limitada Funciones de síntesis: vigilia normal; **atención distráctil**; **memoria muy tomada, sobre todo la de fijación**, aunque después se afecta también la de evocación; desorientación en casos avanzados Funciones de relación: **globalmente afectadas**. Capacidades intelectuales: **muy disminuidas**. Funciones cognoscitivas: **pensamiento concreto**, perseverante, prolijo, a veces delirante Funciones afectivas: indiferencia o labilidad según los casos, explosividad. Conducta: **afección de hábitos, trastornos globales de las necesidades**.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA – SÍNDROMES

SÍNDROME AMNESICO CONFABULATORIO

Descripción general: aspecto descuidado, distraído. **Funciones de síntesis:** vigilia normal; atención distráctil; memoria muy tomada, sobre todo la de fijación reciente, hasta el punto en que el enfermo olvida que minutos antes recibió la visita de su esposa en la sala; hay también confabulaciones; orientación sorpresivamente bastante conservada pese a la afectación amnésica; llama la atención el desenvolvimiento del paciente a pesar de la alteración de su memoria **capacidades intelectuales:** disminuidas. **Funciones cognoscitivas:** pensamiento concreto, perseverante, prolijo. **Funciones afectivas:** generalmente apatía, a veces habilidad o rigidez afectiva. **Conducta:** hipobulia o abulia, descuido de hábitos, alteración de necesidades de sueño y alimentarias.

SÍNDROME APATOABÚLICO

Descripción general: aspecto descuidado, **facies indiferente**. Funciones de síntesis: vigilia normal, **atención distráctil**, hipomnesia, **se puede llegar a la desorientación apática**. Funciones de relación: **muy afectadas**. Capacidades intelectuales: disminuidas. Funciones cognoscitivas: síntomas residuales en percepciones y pensamiento, curso asociado lentificado. Funciones afectivas: **indiferencia**. Conducta: **abulia, hipoquinesia**, toma de necesidades, toma de hábitos.

SÍNDROME ESQUIZOFRÉNICO.

Su denominación, que procede del griego esquizo (roto) y freno (mente), destaca su característica esencial: la expresión de una importante **desorganización de las funciones psíquicas**. La llamada **disociación ideoafectivoconativa**, **elemento cardinal del síndrome**.

SÍNDROME

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

SÍNDROME ESQUIZOFRÉNICO

Característica esencial: desorganización de las funciones psíquicas, **Disociación ideoafectivoconativa**
Paciente con aspecto descuidado, **aislamiento**, dificultades de la comunicación
Funciones de Síntesis: vigilia normal, atención orientada, memoria sin alteraciones, orientación conservada.
Funciones de Relación: **afectación global**.
Capacidad intelectual: sin gran alteración.
Funciones Cognoscitivas: **riqueza alucinatoria sobre todo auditiva, pensamiento autista; bloqueo; disgregación**.
Funciones Afectivas: **disociación ideoafectiva, ambivalencia afectiva**.
Funciones conativas: **abulia, conducta incomprensible**.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA – SÍNDROMES

SÍNDROME DELIRANTE.

Su característica esencial es la **presencia de ideas delirantes**, la **afectación global de las funciones de relación** y la **conservación relativa de las funciones de síntesis**.

SUB- SÍNDROME	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
SÍNDROME PARANOICO	Descripción general: Presencia y comunicación conservada Funciones de Síntesis: vigilia normal, atención a veces hipervigilante, memoria conservada y en ocasiones aumentada, orientación conservada. Funciones de Relación: afectadas en lo relativo al tema delirante Capacidad intelectual: normales o altas. Funciones Cognoscitiva: sin trastornos senso perceptivos, delirio único con argumentación lógica Funciones Afectivas: conservadas, excepto en lo relativo al delirio. Funciones Conativas: hábitos conservados.
SÍNDROME PARANOIDE	Descripción general: Aspecto descuidado y actitud recelosa Funciones de Síntesis: vigilia normal, atención hipervigilante, memoria conservada, orientación conservada. Funciones de Relación: globalmente afectadas. Capacidades intelectuales: conservadas. Funciones Cognoscitivas: alucinaciones auditivas, verbales, ilusiones auditivas, verbales, ideas delirantes de daño, persecución, referencia, y a veces de grandeza o celos. Funciones Afectivas: ansiedad, agresividad. Funciones conativas: conducta concordante con el delirio, afectación de necesidades y hábitos.
SÍNDROME DE AUTOMATISMO PSIQUICO	Descripción general: aspecto descuidado Funciones de Síntesis: vigilia normal, atención dirigida hacia adentro, memoria conservada, orientación conservada. Funciones de Relación: globalmente afectada. Capacidades intelectuales: conservadas. Funciones Cognoscitivas: pseudoalucinaciones auditivas, trastorno del esquema corporal, despersonalización, desrealización, pensamiento autista, bloqueo, delirio influencia, delirio de robo del pensamiento. Funciones Afectivas: apatía, disociación ideofectiva Funciones Conativas: hipobulia, alteración de necesidades y hábitos.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA – SÍNDROMES

SÍNDROMES AFECTIVOS.

Estos síndromes, cuya esencia son las manifestaciones **afectivas y la toma global de las necesidades sin afectación notable de las sensopercepciones**.

SUB- SÍNDROME

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

SINDROME MANIACO	Aspecto llamativo por vestuario y maquillaje exagerado. Funciones de Síntesis: vigilia algo aumentada, atención hipervigilante, memoria aumentada, orientación conservada. Funciones de Relación: globalmente afectada. Capacidades intelectuales: conservadas. Funciones Cognoscitivas: sensopercepciones sin alteraciones, pensamiento acelerado, fuga de ideas. Funciones Afectivas: hipertimia, labilidad afectiva, disforia. Funciones Conativas: hiperbulia, hiperquinesia improductiva, aumento de las necesidades con bulimia, hipererotismo, hipersociabilidad.
SINDROME DEPRESIVO	Aspecto Descuidado y postura flexionada Funciones de Síntesis: vigilia normal, atención hiperconcentrada, memoria disminuida, orientación conservada. Funciones de Relación: minusvalía, retraimiento, reducción de intereses. Capacidades intelectuales: conservadas. Funciones Cognoscitivas: sensopercepciones generalmente sin alteraciones, pensamiento de curso lento, ideas hipocondriacas, y en casos severos ideas delirantes e ideas suicidas. Funciones Afectivas: hipotimia, ansiedad. Funciones conativas: hipobulia, hipoquinesia, alteración de hábitos, toma de necesidades con insomnio, anorexia, hipoerotismo, aislamiento social, disminución de las necesidades vitales.
SINDROME AFECTIVO ANSIOSO	Aspecto angustiado, pupilas dilatadas, manos frías y sudorosas Funciones de Síntesis: vigilia normal o alta, atención discretamente hipervigilante, memoria algo disminuida, orientación conservada. Funciones de Relación: conservadas. Capacidades intelectuales: conservadas. Funciones Cognoscitivas: cenestopatías ocasionales, pensamiento acelerado, temor o enloquecer o morir, expectación de noticias desagradables. Funciones Afectivas: ansiedad, irritabilidad, disforia. Funciones Conativas: hiperbulia, hiperquinesia sobre todo en los pequeños movimientos, afectación variable de necesidades, con insomnio vespertino como elemento característico. Este cuadro se acompaña de manifestaciones vegetativas difusas como taquicardia, palpitaciones, hiperhidrosis palmar, piloerección, crisis vasculares e hipermotilidad intestinal.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA – SÍNDROMES

SÍNDROMES DISCINÉTICOS.

Como se infiere por su denominación, la **manifestación esencial de estos cuadros es la alteración de los movimientos**, que pueden estar anormalmente aumentados o disminuidos, como ocurre en los síndromes hiperkinético y estuporoso, respectivamente

Sus características fundamentales son la inmovilidad y el mutismo, pese a mantener un grado variable de claridad de conciencia, hecho que lo diferencia del coma, donde dicha claridad está totalmente abolida.

SUB-SÍNDROME	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
SÍNDROME ESTUPOROSO	Descripción general: aspecto descuidado. Funciones de síntesis: vigilia normal o baja, atención generalmente hiperconcentrada, memoria normal o disminuida, orientación variable. Funciones de relación: globalmente afectadas Capacidades intelectuales: conservadas. Funciones cognoscitivas: sin alteraciones específicas. Funciones afectivas: la fascia puede expresar pánico, indiferencia, perplejidad o tristeza. Conducta: abulia, acinesia, alteración total de necesidades y hábitos. <u>Existen cuatro formas de estupor:</u> Estupor histriónico: teatralidad, risa y llanto fluctuantes, noxa reciente, ganancia evidente. Estupor situacional: no antecedentes patológicos; situación de gran significado; facies de pánico, sudorosa; no ganancia. Estupor depresivo: Presenta una total inmovilidad, mutismo, negativismo pasivo, su facies es de tristeza marcada (fascias omegas), puede emitir quejidos y a veces corren lágrimas espontáneas por sus mejillas. Estupor catatónico: hay inmovilidad, negativismo, mutismo, flexibilidad cética, retención urinaria, sialorrea. Se acompaña de gran actividad delirante y alucinatoria. Estupor orgánico: existirá un estado de toma de conciencia de tipo Confusional, lo que provoca amnesia de las crisis.
SÍNDROME HIPERCINÉTICO	El aumento de la actividad motora con predominio de los movimientos voluntarios o involuntarios y la notable afectación de la adaptación creadora al medio son los elementos esenciales de este síndrome. Estos pacientes se muestran en extremo inquieto y pueden llegar a encontrarse en verdaderos estados de agitación psicomotora. Existen cuatro modalidades: ➤ Agitación catatónica: negativismo, estereotipias, disgregación y a veces incoherencia, manierismos, llanto o risas, alucinaciones y delirios. ➤ Excitación maniaca: en este cuadro lo que predomina es la hipertimia placentera propia de la manía o hipomanía que tiene el paciente con todo el cortejo sintomático ya descrito en estos casos. ➤ Excitación histérica: Existirá cierta teatralidad en el cuadro, egocentrismo, estrechamiento de la conciencia. ➤ Furor epiléptico: el furor epiléptico es un cuadro de agitación en extremo intenso, conlleva una brutalidad extrema.

PSICOPATOLOGÍA I: SEMIOLOGÍA Y FENOMENOLOGÍA – SÍNDROMES**SÍNDROME HIPOCONDRIACO.**

Aquí los elementos esenciales son la **excesiva preocupación por la salud, el constante temor a la muerte y la autoobservación continua de las funciones corporales más significativas.**

A diferencia de las manifestaciones de los trastornos de somatización y ficticios, donde el énfasis en las preocupaciones se proyecta sobre el síntoma y su atención, en el síndrome que nos ocupa el trasfondo común es el temor a la muerte por vía de alguna afección de mal pronóstico

SÍNDROME	CARACTERÍSTICAS GENERALES
SÍNDROME HIPOCONDRIACO.	Descripción general: comunicación desarrollada en terminología médica Funciones de síntesis: vigilia normal, atención dirigida hacia las funciones corporales con hiperconcentración , memoria conservada, orientación conservada. Capacidades intelectuales: normales. Funciones cognoscitivas: cenestopatías y, en los casos más severos, pueden presentarse alucinaciones y delirios. Funciones afectivas: ansiedad, (hipotimia) . Conducta: reiteradas visitas sin justificación objetiva al médico , discreta toma de las necesidades.

SÍNDROME ASTÉNICO.

Sus constituyentes esenciales son el **fácil agotamiento o cansancio y la irritabilidad, que lleva a frecuentes cuadros de disforia y explosividad**. La intolerancia a los ruidos y las dificultades de atención y memoria son también relevantes.

SÍNDROME	CARACTERÍSTICAS GENERALES
SÍNDROME ASTÉNICO.	Descripción general: aspecto expresivo de cansancio . Funciones de síntesis: vigilia normal, atención discretamente distráctil, hipomnesia de fijación y evocación , orientación normal. Funciones de relación: conservadas. Capacidades intelectuales: conservadas. Funciones cognoscitivas: hiperestesia, cenestopatías , torpeza asociativa Funciones afectivas: Irritabilidad y disforia Conducta: agotamiento fácil, sueño fásico, disfunciones sexuales

SÍNDROME PSICOPÁTICO

Sus constituyentes esenciales son **patrones inadaptativos en el comportamiento**, acusados en el control de impulsos, seguridad personal, autovaloración, auto y heteroexigencia, intereses y modo de satisfacer las necesidades biológicas y sociales

SÍNDROME	CARACTERÍSTICAS GENERALES
SÍNDROME PSICOPÁTICO.	Descripción general: no específico. Funciones de síntesis: sin alteraciones. Funciones de relación: patrones inadaptativos en las relaciones consigo mismo, con los demás y con las cosas . Capacidades intelectuales: conservadas. Funciones cognoscitivas: sin alteraciones específicas. Funciones afectivas: inseguridad, labilidad Conducta: dificultades en el control de impulsos, dificultades sexuales